

01 - 01- Fibromes utérins - Pr. Soummani

C'est une pathologie qui est très fréquente. Elle représente presque une femme sur quatre après 35 ans. Donc, c'est une pathologie qui est très, très fréquente.

Donc, on va essayer de parler de ça. Tout est allumé en vert, donc ça va bien. Donc, voilà, on va commencer par les fibromes du terrain.

Et je pense qu'il y en a des étudiants qui nous, ils ne peuvent voir que si je suis ici ou non. Et moi, d'habitude, je n'ai pas eu l'habitude de travailler assis. Donc, je vais faire les deux.

Ils voient, même s'ils ne voient pas. Et comment je vais faire? Ils ne voient rien? Ah, juste les diapos. Tant mieux.

Donc, je peux être debout. Voilà. Donc, on va commencer par les fibromes utérins.

Donc, je vais être light. Je sais que vous n'avez pas le cerveau pour travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par le plus simple.

D'habitude, je commence par la grossesse extra-utérine. Donc, le fibrome, c'est beaucoup plus simple. Demain, on fera l'endométriose.

La semaine prochaine, incha'Allah, on entamera les autres. Donc, les fibromes utérins, ça s'appelle les fibromes utérins, tout court. Les fibromiomes, le léomiome ou le fibromiome.

Toutes les appellations sont correctes. Le plus simple, c'est le fibrome utérin. C'est une tumeur qui se développe à partir du tissu musculaire lisse de l'utérus.

Donc, c'est une prolifération du tissu musculaire lisse de l'utérus. C'est une tumeur bénigne. Donc, lorsque vous entendez parler de fibrome utérin, c'est une tumeur bénigne.

Moralité, c'est pas une tumeur qui se traite systématiquement. Il y en a qu'on peut traiter, il y en a qu'on surveille et qu'on ne traite pas. Donc, c'est une tumeur bénigne, c'est une prolifération tumorale, donc une prolifération dégénérative du tissu musculaire lisse à partir des éléments conjonctivaux, donc les éléments fibreux de l'utérus.

Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente. Je vous disais que c'est une femme sur quatre, c'est pratiquement 25% des femmes, ont déjà ou elles vont développer une tumeur, un fibrome utérin. Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente.

La symptomatologie de cette pathologie est variable. Ça peut aller de la symptomatique, c'est-à-dire un fibrome qu'a la femme et qui n'a aucun symptôme. C'est en général après un examen échographique chez un médecin généraliste ou une autre spécialité, il découvre qu'il y a une masse au niveau de l'utérus, mais il n'a pas de symptôme.

Donc, ça peut être asymptomatique, mais ça peut être des symptômes qui sont de plus en plus graves. Par exemple, il y a des cas de femmes qui vont venir avec des météorologies très abondantes, parfois même en état de choc. C'est rare, mais ça existe.

On en voit toujours. Donc, de la pathologie asymptomatique jusqu'à l'hémorragie importante et entre les deux, il y a un certain nombre d'autres symptômes que l'on verra par la suite. Je vous ai dit que lorsque vous diagnostiquez un fibrome utérin, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter.

Tous les fibromes ne se traitent pas. On verra les indications de traitement. Le traitement peut être médical comme il peut être chirurgical.

Donc, il y a des fibromes qu'on opère, il y en a d'autres qu'on traite médicalement, qu'on n'opère pas. On verra ça au chapitre du traitement. Voilà quelques objectifs.

Est-ce que vous avez... C'est le même cours de l'année dernière, donc je n'ai pas changé. Est-ce que vous avez eu le cours comme ça ? Si vous avez déjà les plaques, je vais expliquer plutôt que de parler au fur et à mesure. Si vous n'avez pas les plaques, dans ce cas, je dois faire les deux en même temps.

Qu'est-ce que vous... Vous pouvez les prendre. Je ne sais pas où est-ce que vous... Aux alentours de la fac, ceux qui font les photocopies, en général, ils ont tous les cours. Vous pouvez trouver ça.

Comme ça, vous remplissez au fur et à mesure. Ça vous donne plus de temps d'écouter. Le plus important, c'est ça.

C'est d'écouter. J'aime bien, lorsque vous sortez, vous avez au moins 50 à 60 % de cours déjà que vous avez. Il reste les détails pour l'examen.

Le reste, c'est... Voilà quelques objectifs. La définition, on a parlé de ça. On va voir l'épidémiologie et l'anapathie.

On va voir l'étude clinique, les complications et, bien sûr, le traitement. Sur le plan épidémiologique, je vous ai dit que c'est une pathologie qui est fréquente. Entre 20 et 40 % des femmes auront un fibrome utérin.

C'est énorme. En général, il est plus fréquent. C'est une pathologie plus fréquente chez la femme de peau noire.

Les frères, les sœurs subsahariennes, elles ne font pas du fibrome. Elles font beaucoup plus la dénombre de prostate. C'est un peu l'équivalent, pratiquement.

C'est pratiquement une femme sur deux aura un fibrome utérin. 50 % des femmes de peau noire feront un fibrome utérin. Il est plus fréquent chez nous, en Afrique, qu'en Europe.

Mais rassurez-vous, la nature fait l'équilibre parce que chez eux, ils ont d'autres pathologies qui sont plus fréquentes que chez nous. Par exemple, l'endométriose, elle est plus fréquente en Europe qu'en Afrique. Chez nous, les fibromes sont plus fréquentes.

Dans l'Afrique subsaharienne, c'est encore plus fréquent. Là, en général, le fibrome, c'est une maladie de la femme en période d'activité génitale, c'est-à-dire après la puberté, avant la ménopause. Ça ne veut pas dire que la femme ménopausée n'a pas de fibrome.

Si, mais en général, c'est un fibrome qui a été développé avant la ménopause. On ne développe pas un fibrome après la ménopause. On peut l'avoir, certes, parce qu'il était avant et on vient de le diagnostiquer.

Donc, on peut diagnostiquer un fibrome chez la femme ménopausée, mais c'est antérieur à la ménopause, parce que c'est une pathologie de la femme en période d'activité génitale. Le terrain, en général, c'est ce qu'on appelle l'hyper-œstrogénie relative. Vous devez retenir ce mot l'hyper-œstrogénie relative.

Ça veut dire c'est une augmentation d'œstrogène. Ça, vous connaissez. Mais pourquoi relative? Il y a deux sortes d'hyper-œstrogénie.

Il y a l'hyper-œstrogénie absolue. Ça veut dire quoi? C'est une femme chez qui, lorsqu'on fait un prélèvement de sang et on dose l'estradiol, l'œstrogène, on le trouve à des taux élevés par rapport à la population générale. Donc, c'est une femme qui a plus d'œstrogène que le reste de la population.

Ça, c'est l'hyper-œstrogénie absolue. En général, soit ce sont des femmes qui prennent des médicaments à base d'œstrogène, et surtout pour vous, la nouvelle génération de médecins, vous allez être confrontés à beaucoup de choses qu'on n'a pas vécues là. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets.

Maintenant, les femmes achètent des médicaments en ligne. Pas des médicaments en vrai sens de terme, mais des compléments alimentaires. J'ai trouvé pas mal de compléments alimentaires qu'ils proposent en ligne.

Vous pouvez chercher ça. Ce sont des médicaments qui augmentent le volume du sein, qui augmentent le volume des fesses, etc. Vous pouvez voir ça.

Et ils vendent ça en ligne. C'est quoi ça ? C'est des médicaments à base d'œstrogène naturel, végétal. Il existe beaucoup de plantes qui contiennent d'œstrogène, mais ils ont le même effet, ce n'est pas que le médicament.

Faites attention lorsque vous avez une femme, ça va venir, maintenant ça a commencé, pour vous, vous allez trouver pas mal de médicaments en ligne qui sont vendus pour une autre chose

alors qu'ils peuvent développer d'autres choses. Si c'est une femme, vous allez trouver le taux d'œstrogène élevé. Il y a également les tumeurs qui sécrètent des œstrogènes, ça je pense que vous connaissez, c'est au niveau des sérénales, au niveau de l'ovaire, des tumeurs œstrogéniques, c'est des hyper-œstrogéniques, c'est-à-dire ils sécrètent beaucoup plus d'œstrogènes que chez les autres.

Ça c'est l'hyper-œstrogénie absolue, c'est-à-dire vous faites un prélèvement, vous trouvez qu'il y a un taux d'œstradiol élevé. Ça c'est rare par rapport à l'hyper-œstrogénie relative. Qu'est-ce que ça veut dire l'hyper-œstrogénie relative? Ça veut dire que c'est des femmes chez qui, lorsque vous faites un prélèvement sanguin, vous allez trouver que le taux d'œstrogène est normal, comme dans la population générale.

Mais l'effet biologique d'œstrogène est élevé. C'est ce qu'on appelle l'hyper-œstrogénie relative. Pourquoi l'effet biologique est élevé? C'est des questions que vous vous posez je pense.

C'est parce que si vous revenez au cycle menstruel, la première phase c'est la sécrétion d'œstrogène, la deuxième phase c'est la sécrétion d'œstrogène à un moindre taux, mais surtout de la progestérone due au corps jaune. L'ovulation, le corps jaune, après l'ovulation, qui va sécréter de la progestérone. Chez ces femmes qui ont une hyper-œstrogénie relative, ce sont des femmes qui ont un mauvais corps jaune, un corps jaune qui sécrète peu la progestérone.

La progestérone, c'est l'hormone qui va contrecarrer l'effet biologique d'œstrogène. Donc si tu n'as pas assez de progestérone, l'effet biologique d'œstrogène va être plus élevé. Est-ce que vous avez compris ? Donc soit que le corps jaune ne sécrète peu de progestérone, soit que la phase lutéale, vous connaissez la phase lutéale du quatorzième jour, telle les règles.

Ça c'est la phase lutéale où il y a le plateau progestatif, où il y a le plateau lutéal. Il est court au lieu qu'il soit de quatorze jours. Il est de huit jours, six jours, sept jours, neuf jours.

Donc la femme aurait tendance à avoir plus d'effet d'œstrogène parce que ces œstrogènes ne sont pas contrecarrés par la sécrétion de progestérone. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hyper-œstrogénie relative. Le même taux d'œstrogène que chez la population générale, mais l'effet biologique est plus élevé que chez la population générale à cause d'un mauvais corps jaune.

Une mauvaise période lutéale. Il sécrète peu de progestérone. C'est la même chose.

Voilà un peu. Donc, c'est une insuffisance lutéale qui va entraîner une hyper-œstrogénie. Donc ça, c'est le terrain des fibromes utérins.

C'est des femmes qui ont une hyper-œstrogénie relative ou absolue. Bien sûr, lorsque elles prennent des œstrogènes exogènes, ça va être encore... C'est dommage, ils ont... Est-ce que vous voyez? Il y a de l'écriture sur l'écran. Je ne pense pas que ce soit des étudiants parce que c'est l'heure des examens.

10h30, 11h30, c'est l'examen. Donc, ce n'est pas vous. C'est nous.

On trouve également ce qu'on appelle le terrain fibromateux. C'est un terrain qui a tendance à faire plus de fibromes que le reste de la population. En général, c'est des femmes qui sont obèses, ce sont des femmes qui sont hyper-tendues et ce sont des femmes qui ont une dystrophie mammaire.

Une dystrophie mammaire des seins qui sont denses, avec un peu comme s'il y a beaucoup de petits nodules au niveau du sein, avec des mastodynies, des douleurs, surtout avant les règles des seins tendus, etc. Ça, c'est la mastopathie bénigne. En général, ce n'est pas méchant, ce n'est pas quelque chose de grave.

Mais la dystrophie mammaire en général est également due à l'hyperostrogénie relative. C'est pratiquement le même terrain. Pourquoi l'hypertension artérielle ? Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est une coïncidence où il y a quelque chose qui entraîne à la fois l'hypertension et à la fois l'ostrogène ? L'ostrogène, il est cardio-protecteur.

Il protège la femme contre les maladies cardio-vasculaires, les oestrogènes. Pour l'obésité en général, parce que la femme obèse secrète plus d'oestrogènes. Vous connaissez ça, je pense.

Oui ? Non ? Un peu ? Moitié-moitié ? Pourquoi la femme obèse secrète plus d'oestrogènes ? Oui ? Oui, par le tissu graisseux. Le tissu graisseux, en général, il secrète en général des androgènes. Des androgènes, le delta-4-androstenedione, plus exactement.

Le delta-4-androstenedione est sécrété par le tissu adipeux. Ce delta-4, une fois métabolisé, il va subir une transformation pour devenir un oestrone, pas un oestradiol. L'oestradiol, c'est les ovaires qui sécrètent l'oestradiol, mais c'est l'oestrone.

Il y a trois types d'oestrogènes. Il y a l'oestrone, l'oestradiol et l'oestriol. L'oestrone, c'est le tissu adipeux.

L'oestradiol, c'est le cycle folliculaire, c'est le cycle hormonal de la femme. L'oestriol, c'est l'hormone de la grossesse, c'est le placenta qui sécrète l'oestriol. C'est les trois.

L'oestriol, en général, il est protecteur. Par contre, l'oestradiol et l'oestrone, ils sont délétères. Sur le plan anatomopathologique, le fibrome utérin peut être au niveau, ça c'est par rapport à l'utérus, donc il peut être au niveau du corps de l'utérus, il peut être au niveau de l'isthme, il peut être au niveau du col.

Vous connaissez l'anatomie. Il y a le corps, il y a l'isthme et il y a le col de l'utérus. Tout ça, c'est l'utérus et le fibrome peut être au niveau du corps, au niveau de l'isthme et au niveau du col.

Au niveau du corps, il peut être au niveau de toute face antérieure, face postérieure, au niveau des cornes, au niveau des bords, etc. Le développement est partout. Au niveau de l'isthme, il a la

particularité, vous connaissez un peu l'anatomie, vous avez oublié, les pauvres, je sais, il n'y a qu'une citule.

Au niveau de l'isme, à 1,5 cm, il y a le passage de l'urtère. 1,5, ça veut dire s'il y a un développement d'un fibrome de 3 cm au niveau de l'isme, il va comprimer l'urtère. Donc ça, c'est la particularité de l'isme.

Au niveau du col, il ne pose pas beaucoup de problèmes, mais la partie où se développe plus le fibrome, c'est le corps de l'utérus, rarement au niveau de l'isme et au niveau du col de l'utérus. Au niveau de l'utérus, il y a également, il y a la muqueuse, c'est là où se développe l'endomètre. Il y a le myomètre et il y a la serreuse, qui englobe tout.

Elle est très fixée, on ne peut pas. Il est très fixé à l'utérus. Donc, le fibrome peut se développer, soit au niveau de la serreuse, c'est-à-dire au niveau de la région qui est entourée, on va voir les images, entourée par la serreuse et on l'appelle le fibrome sous-serreux.

Soit il est sous la muqueuse, à l'intérieur, il est appelé sous-muqueux, soit il est au niveau de la paroi de l'utérus, au niveau du myomètre, il est appelé le pardon, le fibrome interstitiel. Donc, il y a le fibrome interstitiel, c'est au niveau du myomètre, il y a le fibrome sous-serreux, il y a le fibrome sous-muqueux, sous la muqueuse, sous l'endomètre. Le sous-serreux, il peut être pédiculé comme il peut être sissile.

La même chose pour le fibrome sous-serreux, sous-muqueux. Il a la particularité, le fibrome sous-muqueux, notez-la, le fibrome sous-muqueux a le caractère d'être très hémorragique. Le fibrome sous-muqueux a le caractère d'être très hémorragique.

Voilà un peu l'illustration de tout ça. Donc, voilà, vous avez ici l'utérus, vous avez ici l'isthme de l'utérus et ici le col de l'utérus. Donc, le fibrome peut se développer ici, c'est la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire l'endomètre.

Donc, vous voyez, le fibrome peut être sous la muqueuse. Il est appelé ici, il est sous-muqueux et ici il est sous-muqueux intracavitaire. Vous voyez, il est pédiculé, il est à l'intérieur de la cavité.

Il y a le fibrome interstitiel ici et il y a le fibrome sous-serreux. Regardez, ça c'est un fibrome sous-serreux qui est sissile, il n'a pas de pédicule et là, il y a un fibrome sous-serreux qui a une pédicule, il est appelé sous-serreux pédiculé. Voilà un peu la même chose, un fibrome sous-serreux pédiculé, un fibrome sous-serreux sissile, un fibrome sous-muqueux, un fibrome sous-muqueux intracavitaire et un fibrome interstitiel.

Interstitiel ou intramural, c'est la même chose, vous pouvez dire les deux. Ça c'est une pièce d'hystérectomie, on voit ici le fibrome, on voit ici un autre fibrome, le voilà, et on voit ici la cavité de l'utérus où il y a quelque chose ici qu'il faut aller explorer par hystéroscopie, c'est-à-dire vous pouvez montrer votre hystéroscope, c'est comme le fibroscope, comme matériel optique que

vous allez introduire pour voir ce qu'il y a ici, parce qu'il faut savoir que parfois il y a l'association fibrome et cancer de l'endomètre, ça pourrait être le cas, dans ce cas le pronostic dépend de cette petite lésion qui peut être un cancer de l'endomètre que de ce fibrome. Donc voilà un peu.

Sur le plan macroscopique, vous avez vu les images, c'est une tumeur qui est arrondie au haut valaire, c'est une tumeur qui est ferme, consistance est ferme, c'est une tumeur qui est blanc, acré, et c'est une tumeur qui a une taille variable qui peut aller de quelques millimètres jusqu'à 35-40 centimètres. Donc ça peut être un fibrome de cette taille qui prend pratiquement tout l'abdomen. La taille est variable, le nombre est variable, ça peut être un seul fibrome, ça peut être une trentaine, j'ai opéré des femmes qui ont 24-25 fibromes.

Donc de un à plusieurs fibromes, et c'est une tumeur qui a la particularité de ne pas avoir de capsule. Elle a une pseudo-capsule, mais elle n'a pas de capsule. Elle n'est pas encapsulée.

Donc c'est une tumeur qui est limitée par une pseudo-capsule, mais pas de capsule réelle. Voilà, on a parlé de tout ça. Sur le plan vasculaire, c'est une tumeur qui est vascularisée uniquement par le réseau périphérique.

Donc il y a un réseau périphérique de vaisseaux qui vont donner des petits pellicules qui vont vasculariser le fibrome, mais plus le fibrome est gros, plus le centre du fibrome ne reçoit pas de sang et par conséquent, il a la tendance à s'infarctir. Donc à être ischémique et s'infarctir par la suite. C'est pour ça que c'est une vascularisation qui est précaire.

C'est un petit réseau artériolaire périphérique qui va superficiel, qui va donner des petits artéioles au niveau du fibrome, mais il y a beaucoup d'ischémie au niveau du fibrome. Il y a également l'hémorragie de ce réseau vasculaire périphérique. Et il y a également, parce qu'il est ischémique, il y a la possibilité d'être à l'origine d'accidents thromboemboliques.

La femme qui a un fibrome peut avoir par deux raisons. Premièrement, en raison de l'ischémie, mais également parce qu'il est compressif. Il peut comprimer et lorsque vous enlevez le fibrome, il y a, vous chassez pratiquement des microthrombies qui peuvent aller ailleurs.

Et donc c'est pour ça qu'il est impératif de donner un traitement anticoagulant juste après l'intervention lorsque vous voulez opérer une femme qui a un fibrome. C'est impératif. Au post-opératoire, on doit donner de l'héparine bas-poids moléculaire.

Sur le plan microscopique, il n'y a pas grand-chose. C'est une juxtaposition des tissus conjonctivales et de tissus musculaires lisses, sous forme de faisceau musculaire en tourbillon partout, mais l'élément qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas d'atypie et pas d'orientation architecturale. Je vous ai dit dès le début que c'est une tumeur qui est bénigne.

Faites attention, c'est une tumeur bénigne, mais faites attention aux lésions associées. Ce sont des femmes qui peuvent avoir une hyperplasie endométriale. Ce sont des femmes qui peuvent

avoir de l'adénomyose ou l'endométriose.

Ce sont des femmes qui peuvent avoir un polyfibreux. Le polyfibreux, c'est un peu le fibrome, mais il est à l'intérieur de la cavité de l'utérus. Ce sont également des femmes qui peuvent avoir, malheureusement, un cancer de l'endomètre.

Parfois, les lésions associées font plus le pronostic que le fibrome utérin. Voilà ce que vous aimez plus, l'étude clinique. Je vous ai dit que c'est une pathologie qui peut être asymptomatique.

Ce sont des femmes qui peuvent être tout à fait normales. Elles n'ont aucun symptôme. S'elles présentent des symptômes, le premier symptôme, le maître-symptôme, le chef de file, c'est les ménorrhagies.

Les ménorrhagies, c'est des femmes qui ont des règles qui sont soit abondantes, c'est-à-dire pour un volume très important, ou bien durables. Des femmes qui ont des ménorrhagies qui peuvent aller de 10, 12, 13 jours par cycle, qui peuvent même engendrer des anémies. Donc, c'est les ménorrhagies.

Lorsque les ménorrhagies sont durables, c'est-à-dire vous demandez à la femme combien durent les règles, elle va vous dire 8 jours, 6 jours, 9 jours, 10 jours. C'est quantifiable en termes de journée. Mais comment vous allez évaluer le volume ? Parce qu'il y a des femmes qui ont 5, 6 jours, mais ce sont des règles qui sont abondantes.

Comment vous allez évaluer ces règles ? Comment vous allez savoir que c'est une femme qui a des ménorrhages ? Oui, effectivement, le nombre, combien elle change de couche par jour, mais là également, c'est un peu subjectif parce qu'il y a des femmes qui supportent porter des couches trop mouillées, d'autres qui ne supportent pas. Des femmes qui, dès qu'il y a une ou deux gouttes de sang, elles doivent changer leur couche. Dans ce cas, il faut aller dans les détails.

Quand est-ce que vous changez ? Est-ce que vous changez lorsqu'elle est toute mouillée ou bien vous la changez parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas ? Donc ça, c'est à vous de voir. Je ne peux pas vous dire comment, chaque médecin a sa façon de faire son interrogatoire et c'est comme ça que vous allez parler à la femme pour voir est-ce qu'effectivement c'est des femmes qui saignent beaucoup ou non. Sinon, allez chercher les éléments, l'examen clinique, les signes indirects du saignement, c'est-à-dire les conjonctives, l'atachicardie, on n'arrive pas à la sueur ou l'hypotension parce que c'est des ménorrhagies qui sont chroniques, donc elles n'entraînent pas une hémorragie aiguë, sauf pour le fibrome sous-muqueux, on en parlera, mais le reste ça dure dans le temps.

Vous cherchez les éléments indirects, vous interrogez la femme, quand est-ce qu'elle change les couches, combien des couches, etc. Bien sûr, lorsque la femme te dit que elle mouille même le lit le soir, ça c'est des règles qui sont abondantes. S'il te dit qu'il y a des caillots de sang, ça c'est des règles qui sont abondantes, on n'a pas besoin de couches pour savoir qu'il y a des caillots de

sang, c'est en général des femmes qui saignent.

Donc voilà, c'est des ménorrhagies, c'est le signe le plus fréquent, c'est le plus évocateur lorsque la femme consulte pour des ménorrhagies, le premier diagnostic à évoquer c'est le fibrome utérin. Et c'est qui sont d'abondance et de durée variable d'une femme à une autre. Deuxième signe qui est moins fréquent, c'est les métrorrhagies.

Les métrorrhagies en général ce sont les ménorrhagies, c'est les règles, les métrorrhagies c'est le saignement entre les règles. La femme fait ses règles et puis elle n'a plus de saignement trois, quatre, cinq jours plus tard, elle ressaigne et ça c'est des métrorrhagies. Il faut faire attention, le fibrome entraîne rarement des métrorrhagies, sauf le fibrome sous muqueux.

Le fibrome sous muqueux entraîne des métrorrhagies parce que sous l'endomètre il va biser l'endomètre et l'endomètre va saigner. Le fibrome sous muqueux entraîne des métrorrhagies. S'il n'y a pas de fibrome sous muqueux et la femme a des métrorrhagies, il faut aller chercher d'autres étiologies des métrorrhagies.

Par exemple le cancer de l'endomètre, lui il donne des métrorrhagies. Par exemple la grossesse extra-utérine, elle, elle donne des métrorrhagies. Mais en général le cancer du col de l'utérus, il donne des métrorrhagies.

Mais le fibrome, rarement, il donne des métrorrhagies. Il y a également les métrorrhagies qui accompagnent les ménorrhagies. Ce qu'on appelle les ménométrorrhagies.

C'est des femmes qui ont des règles qui sont abondantes ou qui durent dans le temps, elles s'arrêtent et après la femme reprend le saignement. C'est les ménométrorrhagies. Il y a également les douleurs pelviennes.

En général, le fibrome utérin n'est pas douloureux. Il n'entraîne pas de douleurs. Ou très rarement.

Lorsqu'il est grand, par exemple si tu as un fibrome de 10 cm de diamètre ou 12 cm de diamètre, c'est l'équivalent d'un kilo de poids. Donc vous voyez si la femme a un kilo de poids au niveau du pelvis, c'est quand même une pesanteur. Donc il va sentir une pesanteur.

En général, les fibromes donnent une douleur à titre de pesanteur lorsqu'ils sont gros. Ou bien lorsqu'ils sont compliqués. Un fibrome compliqué entraîne de la douleur, par exemple une hémorragie superficielle, par exemple l'infarcissement du fibrome, par exemple la nécrobiose du fibrome.

Ça entraîne la torsion du fibrome lorsqu'il est pédiculé au niveau de l'abdomen. Ça, c'est des fibromes qui deviennent douloureux. Mais un fibrome non compliqué, de petite taille en général, il n'entraîne pas de douleur.

Il y a également les hydrorées. Les hydrorées, c'est un micoulement. C'est comme les leucorrhées, mais ils ne sont pas infectés.

Il n'y a pas de douleur. C'est comme le liquide. C'est du liquide qui sort de l'utérus de la femme.

C'est les hydrorées. Et il y a, bien sûr, une femme qui a un fibrome de 20 ou 15 centimètres. Elle va consulter pour une masse abdominale ou abdominopelvienne.

Elle va voir elle-même qu'elle a le ventre qui va se gonfler. Lorsque vous allez palper, vous allez trouver une masse abdominale ou pelvienne. Il y a également les signes compressifs.

Par exemple, si le fibrome se développe au niveau de la paroi antérieure de l'utérus, il va comprimer la vésicule. Donc vous allez avoir des dysuries, des pollakiuries, parfois l'impériosité émissionnelle. Vous pouvez l'avoir dû à la compression.

S'il est au niveau de la paroi postérieure, il va comprimer le rectum. Donc vous allez avoir un ténelisme, etc., des troubles. Donc il y en a. Parfois, d'emblée, vous allez perdre le diagnostic à cause d'une complication.

Une femme qui n'a rien, un jour elle va venir avec des douleurs pelviennes aiguës, vous examinez une dyspareunie, vous faites l'échographie à un fibrome, il est tordu, donc c'est pour ça la femme a consulté. C'est une complication du fibrome. Je répète que dans 30 à 40 % des cas, même plus, le fibrome n'entraîne pas de symptômes.

Il est asymptomatique. Donc, voilà un peu ça. L'examen de la femme, là aussi, pour l'examen, vous êtes libre de faire votre examen comme vous le voyez.

Il y en a qui commencent par l'examen. Moi, personnellement, je commence par la palpation de l'abdomen. Je ne commence pas.

Il faut dire qu'en gynécologie, c'est un peu difficile. Il faut aller doucement pour examiner la femme. Je ne peux pas dire à la femme, allez-y, je vais faire un toucher d'emblée.

Ça fait... C'est un peu stressant pour la femme. Donc, commencez à être plus loin de l'appareil génital. Commencez par l'abdomen, commencez par les mollets à la recherche de varices, commencez par la tension artérielle, le pouls, la température, les conjonctives, etc.

Et puis, vous examinez, vous faites votre spéculum et après, vous mettez votre toucher vaginal pour voir ce qu'il y a. Donc, vous commencez. Moi, personnellement, je commence toujours par l'abdomen. Inspectez l'abdomen.

Est-ce qu'il y a une boussure? Est-ce qu'il y a une augmentation du volume de l'abdomen? La palpation, si le fibrome est volumineux, vous allez le palper. En général, c'est une masse qui est ferme et qui est bien limitée et qui balote entre les mains parce qu'il est mobile. Rapidement,

vous allez dire que ça, c'est un fibrome.

Il y en a, les tumeurs ovariennes, surtout bénignes, qui peuvent donner le même aspect, mais en général, c'est des fibromes. Et puis, le saignement, le spéculum, vous mettez votre spéculum pour voir le col. D'abord, le sang provient de la cavité, provient de l'intérieur.

Vous allez voir la femme avec du sang qui provient de l'intérieur, donc c'est un écoulement sanguin endocervical. C'est une occasion, si la femme n'a jamais fait ou a fait il y a longtemps un frottis cervico-vaginal, à condition qu'elle ne saigne pas. Parce qu'il ne faut pas faire de frottis.

Il faut faire un frottis cervico- vaginal. Si elle saigne ou s'il a des leucorrhées, ne faites pas de frottis parce que c'est une perte d'argent. L'anapath, le cytologiste, ne va trouver que des hématites si la femme saigne ou bien des polynucléaires neutrophiles chez la femme qui a des leucorrhées.

Donc, il vaut mieux attendre que la femme soit propre pour faire le frottis propre. Pas le sang figuré, c'est-à-dire ni règles, ni le coré. Voilà ce que ça veut dire être propre.

Et refaire l'examen par la suite. Et puis, le touché vaginal, il est important lorsque vous faites votre examen, d'avoir un touché vaginal au niveau du vagin jusqu'au niveau du col et l'autre main, elle doit appuyer sur le fond de l'utérus. On fait comme ça, le touché vaginal.

Cette main va prendre le fond de l'utérus et va le rapprocher vers les doigts du vagin. Au début, vous allez voir, vous allez être frustré. C'est tout à fait normal.

C'est le début. Mais après, essayez de faire beaucoup d'examens chez des femmes qui sont normales. Si vous savez faire l'examen gynécologique chez une femme normale, dès qu'il y a une pathologie, vous allez la reconnaître.

Donc, toujours le touché. Il n'y a pas de touché vaginal avec une seule main. Comme ça.

Cette main, au niveau du vagin jusqu'au niveau du col et l'autre main au niveau de l'abdomen, elle cherche le fond de l'utérin et elle va appuyer sur le fond de l'utérin pour rapprocher l'utérus vers les doigts. Et les doigts vont ressentir si il y a une masse latérale utérine, une masse pelvienne, si l'utérus est augmenté de volume comme c'est le cas en cas de fibromes, il y a un utérus qui est augmenté de volume et s'il y a plusieurs fibromes, vous allez trouver que ses limites sont irréguliers parce qu'ils sont déformés par les fibromes. S'il y a un seul fibrome, vous allez palper l'utérus avec la masse.

Avec la masse elle a du doigt comme une pinceau du doigt c'est quelque chose de nouveau c'est c'est non non Nan Non Le On va voir, est-ce que vous entendez ? Donc voilà, ça c'est l'utérus. Et ça en général c'est la cavité de l'utérus. Et ici il y a le vagin.

C'est flou, c'est ok. Ici vous avez vos doigts du toucher vaginal et voilà. Et l'autre main, elle doit

appuyer sur le fond de l'utérus, comme ça.

Et vous pouvez avoir beaucoup de choses lorsque vous faites ça. La première des choses, c'est que vous allez trouver un peu ça, des fibromes ici. Un autre peut-être ici.

Donc la première des choses, c'est que l'utérus est augmenté de volume et il est bousillé parce qu'il y a beaucoup de fibromes. Mais il peut être un seul fibrome que vous allez palper qui va faire augmenter le volume, mais à côté vous allez trouver la masse. Parfois si la masse est au niveau de la paroi de l'utérus, vous n'allez pas sentir la masse.

Vous allez trouver que l'utérus est augmenté de volume, mais il n'y a pas de masse. Vous ne pouvez pas palper, par exemple, une masse ici. S'il est là, bon, c'est des signes indirects.

C'est le fibrome, c'est l'utérus qui augmente de volume, mais vous n'allez pas palper le fibrome. Par contre, lorsque vous avez ça, ça c'est un fibrome qui est sous serreux et qui est sessile, il n'y a pas de pédicule. Si vous avez ça, vous allez sentir cette masse ici.

C'est une masse que vous allez sentir qui n'est pas séparée de l'utérus et qui fait corps avec l'utérus. Comment vous allez le faire pour savoir qu'il fait corps avec l'utérus ? Ah, là je vous explique, c'est là, c'est le bouton. Parce que l'enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui dit « tu as marre ou non ? » Indirectement.

Elle fait un an ça pour moi, moi je suis technologien. Chaque fois il me change ça, on n'est pas censé connaître toute la technologie. Vous savez les drones ? Les drones, les drones de la Russie, les ukrainiens.

Ça, je l'ai dit. Donc, comment vous allez voir quels sont les signes par le toucher vaginal qui vont vous permettre de dire « cette masse fait corps avec l'utérus » ou « cette masse est latéro-utérine, à côté de l'utérus » ? C'est deux signes. Premièrement, il n'y a pas de sillon de séparation.

Vous n'allez pas trouver ici un sillon qui sépare l'utérus de la masse. Ça, c'est le premier signe. Je vais vous montrer par la suite le sillon de séparation.

Deuxième, c'est que lorsque vous palpez, vous faites une palpation au niveau de la masse, au niveau de l'utérus, vous n'allez pas ressentir les mouvements que vous allez donner à la masse. Lorsque la masse fait corps avec l'utérus, si vous faites des mouvements, vous mettez des mouvements au niveau de la masse et elle est ressentie parce qu'elle va être... C'est des ondes. Elles vous aiment.

C'est la même chose. Et puis, il y a des ondes qui vont arriver au niveau de votre doigt parce que c'est l'utérus qui va faire circuler les ondes. Par contre, regardez, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, j'ai un fibron qui est pédiculé.

C'est celui-là. C'est celui-là. C'est le pédiculé.

Bon, peu importe. Ici, il y a un sillon de séparation. Bien sûr, les doigts se dérangent.

Il y a un sillon de séparation là que vous allez sentir. Vous allez trouver qu'il y a un sillon, il y a le fibron là, l'utérus est là, le fibron est là. Entre les deux, il y a un sillon de séparation qui sépare les deux.

Lorsque tu as ça, c'est une masse latérale utérine et non pas une masse utérine. Et deuxième chose, si vous mettez des mouvements ici, vous n'allez pas les ressentir là. Si vous mettez des mouvements ici, vous palpez ici, vous n'allez pas les ressentir parce que l'utérus ne peut pas faire partir les ongles.

Est-ce que vous avez compris ? Les mouvements imprimés à la masse ne sont pas ressentis au niveau des doigts vaginaux. Ada Wolfhard-Mabin a une tumeur utérine et une tumeur latérale utérine. Dans la tumeur latérale utérine, il y a un sillon de séparation que vous allez toucher et les mouvements imprimés à la masse ne sont pas ressentis au niveau des doigts vaginaux.

Par contre, la masse utérine, les mouvements imprimés à la masse sont ressentis au niveau des doigts vaginaux et il n'y a pas de sillon de séparation. C'est important parce qu'on va parler de ça dans plusieurs pathologies. Ça, c'est en général, ils doivent être enseignés de la sémiologie, mais malheureusement, ils ne nous donnent que quelques jours.

Alors, à partir de la sémiologie, parce qu'ils disent toujours non, la cinquième année, vous aurez la pathologie et vous expliquez tout. Mais c'est important en gynécologie de savoir ça. C'est la première des choses pour commencer à faire des touchés.

Incha'Allah, tout le monde va passer par la gynécologie en cinquième année, en sixième année. C'est dommage que les stages sont de plus en plus courts. Il y avait 14 mois.

14 mois de gynécologie en cinquième année et trois mois en sixième année. Et puis, c'est un stage obligatoire, le stage de faisant fonction, stage interdit. Donc, vous voyez, il fasse pratiquement une année la gynécologie.

Pratiquement, 4 plus 3 plus 3. Ça fait dix mois. Il y a une semaine. Six semaines, ce n'est même pas... Vous n'allez rien apprendre en six semaines.

Malheureusement. Moi, je me dis, tant pis pour vous, tant mieux pour nous. Comme ça, on n'aura pas de concurrents.

J'ai des postes, j'ai des collègues. Avant, j'étais enseignant à Gaza. L'étudiant en cinquième année, comme objectif de stage, il devrait valider le stage.

Il doit faire au moins trois rapprochements, au moins cinq à six réflexions d'études autonomes.

Sixième année, obligatoirement, il doit faire un stage homostatique d'abord et d'un an. Là-bas, tu ne peux pas faire ça parce que tu vas prévenir l'étudiant.

Il a peu de temps pour faire tout ça. Donc, tu ne peux pas. Ça, c'est la différence.

Peut-être parce qu'on a assez. Mais vous savez que... Pourquoi l'objectif est un peu... C'est l'objectif de l'activité. De l'activité obstétrique.

De l'activité gynéco-obstétrique, 85 %, c'est de l'obstétrique. C'est l'accouchement, la pathologie de la grossesse, qui est parmi les premières causes de mortalité de la femme. L'hémorragie de la délivrance, l'hypertension artérielle au cours de la grossesse.

Ça, les avortements et les problèmes par la suite, les infections, etc. C'est... La femme paie un lourd poids dans ça. Par conséquent, si j'avais le pouvoir politique, le pouvoir politique de l'enseignement, le médecin monichralat, tout médecin généraliste au Maroc doit être capable de faire face à ces complications.

Parce que là, moi, je suis au CHU depuis ma naissance, ma naissance médicale, c'est-à-dire... Par exemple, je suis né au terrain de Raja. Donc, je suis né au terrain de Raja. Je suis allé au hôpital, mais on entre à l'hôpital, l'intern de CHU, entre à 24 ans.

24, 25 ans. C'est comme ça. Depuis lors, je ne suis pas allé au CHU.

Donc, vous voyez... Mais les femmes qui sont à la périphérie ne vont pas me voir. Elles vont voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste, que ce soit dans un cabinet privé ou dans l'État.

Je vois mal un médecin généraliste qui ouvre son cabinet privé dans un village, Kéynin, et il ne sait pas faire un accouchement, par exemple. Alors qu'à côté, il y a une matrone qui fait l'accouchement. Donc, ce n'est pas le cas.

Le médecin généraliste fait l'accouchement. Et il doit le faire. Moi, personnellement, le médecin doit savoir faire un accouchement.

Donc, voilà. Je vais tenter... Est-ce que c'est OK pour la masse latérale utérine et la masse utérine ? En nom de Dieu. C'est le bouton qui fait la couleur verte.

C'est le bouton qui fait la couleur verte. Donc, voilà un peu... Vous allez trouver tout ça ici. C'est une masse plus ou moins régulière, qui est arrondie, ou bien oblongue, qui est lisse, qui est ferme, un peu de dureté.

Et elle est indolore, sauf si le fibrome est compliqué. S'il n'est pas compliqué, l'utérus est mobile, il n'y a pas de problème. Et... Parfois, il est à l'intérieur du pelvis.

Parfois, il déborde au niveau de l'abdomen, lorsqu'il tourne, forcément. Et puis, il est solidaire à l'utérus. C'est le cas qu'il est attaché à l'utérus, que je viens d'expliquer.

Les examens complémentaires. Le premier examen, bien entendu, c'est l'échographie. Aujourd'hui, la majeure de la salle d'accouchement m'envoie un message me disant... Les centres de l'échographie sont en panne.

Lorsque l'échographie est en panne, le gynécologue est en panne. C'est obligatoire. Actuellement, l'échographie, c'est la continuité immédiate de l'examen physique, l'examen gynécologique.

Donc, l'échographie est systématique. Il va permettre de faire le diagnostic parce qu'il va montrer une image qui est éogène. Elle a la même structure que l'utérus, qui est bien limitée, qui est éogène, qui est homogène.

Sauf si c'est compliqué, il devient hétérogène et qui est au niveau de l'utérus. Il va vous permettre de connaître le nombre de ces images, combien de fibromes il y en a. Deuxièmement, la taille des fibromes. Parfois, c'est quelques millimètres jusqu'à 30-35 centimètres.

Donc, la taille, le nombre, la position. Est-ce qu'ils sont au niveau du corps de l'utérus, de l'élisme, au niveau du col, la face antérieure, la face postérieure, les bords, etc. Et bien sûr, ça va vous permettre d'éliminer une cause anxieuse, surtout une tumeur ovarienne, qui peut donner le même aspect clinique, physique.

C'est-à-dire, à l'examen, vous pouvez trouver une tumeur ovarienne qui a les mêmes caractéristiques physiques que le fibrome sous ses repédiculés. Les deux sont latéraux utérines. Donc, voilà un peu de fibrome.

Vous allez voir, ça, c'est l'utérus, et voilà le fibrome. Donc, voilà. Mettez ça, écrivez ça.

Il est en ligne, gratuitement. alie-abara.com C'est ouvert pour tout le monde. Donc, vous pouvez trouver pas mal d'images, pas uniquement de ça, mais d'autres choses.

Donc, voilà un peu le fibrome, l'endomètre et l'utérus. Voilà ici un fibrome interstitiel, le voilà. Il est un peu hétérogène, ça veut dire qu'il y a du liquide à l'intérieur.

Et à côté, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ici un sac gestationnel. C'est une femme qui a un fibrome et qui est enceinte. Voilà l'embryon.

Donc, ça, c'est des éventualités que vous pouvez trouver. Donc, vous voyez, peut-être cette femme n'avait aucun symptôme. Elle est tombée enceinte.

Elle est allée voir le gynécologue pour diagnostiquer la grossesse. Il fait l'échographie, il trouve le sac gestationnel et à côté, il trouve un fibrome. Peut-être, je ne sais pas.

Voilà, si vous faites l'IRM, vous allez trouver un utérus qui est myomateux, il est bosselé,

plusieurs myomes. Donc, ça également. Pour moi, l'IRM n'est pas un examen systématique pour le diagnostic des fibromes.

Contexte, vous devez demander une IRM. Lorsque vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre le fibrome de l'utérus et une tumeur ovarienne. Lorsque vous avez, parfois, il y a des difficultés pour dire est-ce que c'est une tumeur ovarienne ou un fibrome utérin.

Pourquoi ? Certes, les deux, vous allez les opérer, mais le fibrome, la chirurgie n'est pas la même. C'est deux choses qui sont, lorsque vous opérez une tumeur ovarienne, il y a le risque de malignité. Donc, la femme doit être bien préparée, etc.

Alors que si c'est un fibrome, le problème est beaucoup plus simple que le risque. Donc, voilà. La radio de l'abdomen, son préparation, parfois, on demande ça lorsque c'est un fibrome qui est calcifié.

C'est une femme âgée, ménopausée, chez qui on peut trouver un fibrome ancien. Donc, il doit être, il est, il se trouve des calcifications au niveau du pelvis, sont circulaires. L'hystérosalpingographie, vous notez, s'il vous plaît, qu'elle n'a pas d'indication dans le diagnostic de fibrome, sauf dans le cadre d'une infertilité.

Si la femme vient consulter pour une infertilité, vous faites votre échographie, vous allez trouver que la femme a un fibrome utérin. Vous devez voir, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre le fibrome et l'infertilité ? Est-ce que, par exemple, le fibrome comprime l'atome ? Dans ce cas, vous demandez une hystérosalpingographie. Sinon, il n'y a pas d'indication de l'hystérosalpingographie dans le fibrome utérin.

L'hystéroscopie, vous connaissez l'hystéroscopie ? Non ? Vous connaissez la cystoscopie ? Non ? L'hystéroscopie, c'est un peu plus petit que le cystoscope. C'est une tige métallique. Il y a des fibres cliques à l'intérieur que vous allez mettre à l'intérieur de l'utérus pour voir la cavité au niveau de l'écran.

Ça a développé l'eau. Vous connaissez l'eau ? Oui, il y a cette évolution. Donc, vous mettez et vous voyez l'intérieur de la cavité.

Moralité conteste, on doit faire l'hystéroscopie. Lorsque le fibrome est intracavitaire ou bien c'est un fibrome qui est sous-muqueux. C'est les deux fibromes qu'on voit par l'hystéroscopie.

À condition que ce soit des fibromes qui ne dépassent pas les 5 cm. Parce que si le fibrome est à l'intérieur de la cavité, il est grand, on ne peut pas passer pour voir. Donc, il va boucher, il va bloquer la vue et vous n'allez rien voir.

Si c'est un petit fibrome, vous pouvez le voir et vous pouvez même l'opérer par hystéroscopie. Vous n'avez pas besoin d'opérer la femme. Donc, la TDM et l'IRM, on en a parlé.

L'échographie rénale, en général, personnellement, lorsque je fais une échographie et je diagnose qu'il y a un fibrome, je cherche toujours les reins pour voir s'il y a une dilatation piello-calicielle. Parce que je dis que le fibrome peut comprimer l'urter. Parfois, vous allez trouver des difficultés à faire la part des choses entre un fibrome et une tumeur ovarienne.

Dans ce cas, vous pouvez aller jusqu'à faire une sérioscopie pour voir si c'est une tumeur ovarienne ou un fibrome utérin. Il y a les complications hémorragiques, les ménorragies qui peuvent être abondantes en entraînant de l'anémie. Ça peut être des métrorragies abondantes, surtout dans les fibromes soumieux ou les fibromes intracavitaires qui peuvent saigner.

Il y a les complications mécaniques. On en a parlé. Une torsion du fibrome sous ses repédiculés ou bien une compression de la vésicule, de rectum, de l'urter, les vaisseaux, les nerfs, c'est rare, mais ça peut exister.

La nécrobiose aseptique, c'est-à-dire le fibrome qui est mal vascularisé, il va s'ischémier, il va se nécroser. Ça, c'est la nécrobiose aseptique. Il n'y a pas d'infection.

Ça, en général, va donner de la douleur, même de la fièvre, parfois une défense pelvienne, parfois des métrorragies. À l'échographie, au lieu d'avoir une image écho-gène, homogène, vous allez voir une image écho-gène, hétérogène parce qu'il est infarci, il y a du liquide. Donc, il va donner ça.

Faites attention. Le saignement dans la nécrobiose aseptique est noirâtre. Deuxième chose, la nécrobiose septique.

Il y a également la nécrobiose septique. La nécrobiose septique, c'est après un avortement ou après un accouchement, il y a la montée des bactéries qui vont aller infecter le fibrome et qui va entraîner une nécrobiose, dans ce cas, septique, c'est-à-dire c'est comme un abcès profond, une fièvre oscillante, douleur profonde, etc. Ça, c'est sérieux parce qu'il faut traiter l'antibiothérapie, la récidive de glace, même parfois la réanimation, etc.

La transformation odémateuse, c'est la nécrobiose aseptique. Les calcifications, un fibrome très ancien peut se calcifier en périphérie. La transformation sarcomateuse, c'est-à-dire les sarcomes utérins.

Personnellement, je dis non. Le fibrome, c'est le fibrome, le sarcome, c'est le sarcome. Si on a diagnostiqué un fibrome, après on a trouvé un sarcome, soit c'est un sarcome qui a été né après, soit le premier fibrome, on a fait une erreur de diagnostic, on n'a pas vu les atypies cellulaires.

Mais le fibrome utérin ne se transforme pas en sarcome. J'ai mis incertain, mais c'est peu probable. Voilà les calcifications.

Un fibrome calcifié. Le fibrome avec un stérilet, le voilà. Vous voyez le stérilet ? Ça, c'est le stérilet.

Regardez ce qu'il y a. Ça, c'est des plages d'un fibrome calcifié. C'est des choses que vous pouvez trouver les complications gravidiques, c'est-à-dire les complications de fibrome qui affectent la grossesse. Premièrement, l'infertilité.

Il y a des cas où la femme a des problèmes. L'infertilité, les fausses couches. Le fibrome, il va jouer le rôle d'épine irritative qui va déclencher des contractions qui peuvent entraîner un avortement, qui peuvent entraîner un accouchement prématuré, qui peuvent entraîner un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta bas inséré.

Normalement, le placenta s'insère au niveau du pont de l'utérus. Lorsqu'il s'insère au niveau du segment inférieur, c'est un placenta prévia. Vous allez voir tout ça, placenta prévia, dystocie mécanique, dynamique, hémorragie de la délivrance, nécrobiose septique dont je vous ai parlé.

Tout ça va être, chacun d'en reconnaître un chapitre. Donc, ne vous en faites pas. Après, vous allez faciliter l'apprentissage en lisant.

Après, vous allez faire les liens entre les cours qui vont vous simplifier l'apprentissage pour l'examen. Si vous faites comme ça, vous allez trouver qu'il n'y a pas de problème et même apprendre rapidement un mois après l'examen. Mais si vous laissez tomber tout ça pendant un mois, vous allez trouver des difficultés.

Je parle en connaissance de cause. La gynécologie obstétrique, c'est long, c'est 70 heures. Et 70 heures, c'était 90 heures.

70 heures, ça ne veut pas dire qu'on a diminué, mais on a condensé. C'est-à-dire lorsque j'avais deux heures pour parler des fibromes utérins, maintenant, j'ai une heure et demie. Vous voyez ce qui s'est passé? Lorsque j'ai deux heures, j'insiste, je répète.

J'insiste. Parce que je redis la même chose deux, trois, quatre fois. Ça, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi.

Parce que c'est important. Comme ça, l'examen va être facile. Personnellement, vous avez peut-être discuté avec les promotions.

Je ne cherche pas la petite bête. Je cherche, est-ce que l'étudiant a préparé ses cours ou non? Tout simplement. S'il a bien préparé ses cours, il va réussir.

En général, on n'a pas de problème. 75 % de la première session. On n'a pas de problème.

Mais comment c'est tout? Je parle parce que j'en ai des enfants. Et puis des enfants, même pas dans la médecine, mais ils ont des problèmes. Bon, le traitement, je disais que le traitement n'est

pas symptomatique.

Toutes les femmes qui ont un fibrome ne sont pas à traiter systématiquement. Donc, ne faites pas cette erreur. Il y a des femmes qui ont un fibrome et des femmes qui ont un fibrome.

Donc, il y a des femmes qui ont un fibrome et des femmes qui n'ont pas. Ce n'est pas le même. C'est très compliqué.

Il y a des femmes qui ont un fibrome et des femmes qui n'ont pas. C'est très compliqué. Lorsque vous êtes dans le cas de l'infant, c'est les trois qu'on a, il y a les prégnants, les nord-prégnants et les estragnes.

Les estragnes sont très androgéniques, les prégnants sont moins androgéniques mais moins efficaces, les nord-prégnants sont moins androgéniques et plus efficaces. C'est pour ça qu'on a les nord-prégnants. Vous les donnez, il y a plusieurs, soit du 6e au 25e jour, soit du 11e au 25e jour, soit du 16e au 25e jour.

En fonction du tableau clinique, donc le 6e au 25e jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles, vous comptez 5 jours, le 6e jour, vous commencez. Ou bien vous comptez dès le 1er jusqu'au 11e jour et vous commencez, ou bien jusqu'au 16e jour et vous commencez. Il y en a qui vont prendre 20 comprimés, il y en a qui vont prendre 15 comprimés, il y en a qui vont prendre 10 comprimés, un seul comprimé par jour.

Donc voilà, ça c'est les progestatifs de synthèse. Il y a les agonistes LH-RH, c'est quoi ? C'est une ménopause médicamenteuse. Donc ils bloquent l'axe hypothalamo-hypophysaire, plus de FSH, plus de LH, plus de cycles menstruels, c'est une ménopause.

Et puisque le fibrome est dû à une hyperostrogénie, vous allez amputer l'utérus de ces oestrogènes, donc en général il ne va pas, il va diminuer de volume, mais il ne va pas disparaître. Rien ne fait disparaître un fibrome, ça c'est un traitement symptomatique. Et puis, bien sûr, si la femme est anémique, bien sûr vous allez lui donner du fer, s'il a des douleurs, vous allez lui donner des antalgiques, une nécrobiose, vous allez lui donner des antalgiques, parce que des antalgiques, c'est de la fièvre.

Et puis vous allez à la chirurgie, donc les moyens thérapeutiques, l'abstention, le traitement médical, le fer, les analogues LH-RH ou les progestatifs. Deux synthèses, je parle bien de synthèse, ne donnez pas l'ultragestane, ne donnez pas la progestérone naturelle, comme le médicament à base de progestérone naturelle, qu'on donne plus souvent et qui n'a aucune indication de fibromes. Les progestatifs de synthèse, c'est en général, soit il y a deux, il y a le luténil, il y a le surgestone, c'est les deux que je connais ici au Maroc, donc c'est les deux qu'on donne en général.

Troisième, bien sûr, il faut donner du fer, et troisième, la chirurgie. La chirurgie, vous pouvez faire

la chirurgie par la parotonie, vous pouvez faire la chirurgie par la voie vaginale, c'est-à-dire par en bas, et vous pouvez faire la chirurgie par stéréoscopie ou hystéroscopie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Soit la myomectomie, c'est-à-dire vous enlevez le fibrome.

Il faut savoir que le fibrome utérin, même que c'est une chirurgie simple, mais ça saigne, donc il faut toujours prévoir du sang. Bien sûr, plus le nombre de fibromes est élevé, plus la femme va saigner trop, donc il faut demander du sang. Soit la myomectomie, c'est-à-dire enlever le fibrome, soit l'hystérectomie, c'est-à-dire enlever l'utérus.

Nous allons voir, pas toutes les femmes qui ont un fibrome, vous allez le refaire, sinon une femme sur quatre va subir une hystérectomie. Non, ce n'est pas compte, des indications. La règle, c'est l'abstention, puisque 30 à 40 % des cas sont asymptomatiques.

Quand ils sont asymptomatiques, vous ne faites rien. Donc, si la femme est asymptomatique, s'il a des fibromes de petit volume, s'il a des fibromes qui ne sont pas compliqués, dans ce cas, l'abstention thérapeutique. Donc, abstention, c'est la règle pour les fibromes de petit volume, asymptomatiques, non compliqués.

Pourquoi vous allez traiter une femme qui n'a rien et qui a un petit fibrome, que vous savez que c'est une tumeur bénigne ? Vous ne faites rien, mais vous expliquez à la femme qu'elle n'a rien, qu'elle a une petite quelque chose au niveau de l'utérus qui n'est pas grave, qui n'est pas dangereux. Moi, je connais une fille qui est venue, elle avait 20 ans, 21 ans, j'étais à casa, elle est venue parce que le médecin traitant, gynécologue traitant, elle allait se marier et lui a dit si elle n'enlève pas le fibrome avant le mariage, elle n'aura jamais la possibilité d'avoir des enfants. Mais vous voyez, oui, la douleur des uns, les autres trouvent leur intérêt.

Je me souviens de ce qui s'est passé hier à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, j'étais malade, ils m'ont offert du pain et j'étais malade. C'est le malheur de toute une nation.

Il y en a qui est à l'hôpital, j'ai eu un rendez-vous avec un médecin, il m'a dit que j'avais un tremblement. Ça, c'est... Lorsque tu trouves un médecin qui dit ça à une femme, ça veut dire que c'est un charlatan, tout simplement. Donc, il faut expliquer à la femme qu'il n'a rien, qu'il n'a rien, que ce n'est pas dangereux.

Si vous ne lui expliquez pas, il va aller, il va trouver un autre médecin, il va lui dire qu'il n'a pas compris ce qu'il a dit, il va lui dire ce qu'il a dit. Il a besoin de radiothérapie et de chimiothérapie. Il est en rémission maintenant.

Donc vous voyez alors que l'autre, il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un que je connais qui sait ce qu'il fait. Il sait que ça peut ne pas être un carcinome.

Ça peut être un lymphome. Ils sont très fréquents au niveau du larynx. Pas aussi fréquents, mais ça existe.

Donc pas de traitement de cancer sans biopsie, moralité. Toutes les pathologies, si vous n'avez pas de biopsie, il ne faut pas opérer pour un cancer. On n'opère pas pour un cancer.

Donc l'embolisation, c'est-à-dire que vous connaissez la radiologie interventionnelle. Ils mettent des cathéters, ils embolisent l'artère utérine qui va diminuer la vascularisation de l'utérus. Mais en général, on fait ça lorsque la femme saigne trop en attendant l'intervention.

Quelles sont les indications? Les indications, comme la règle, c'est l'abstention. Les fibromes de petits volumes asymptomatiques non compliqués. D'accord? Si le fibrome est symptomatique, vous allez... Oui, si le fibrome... Si vous avez un fibrome qui est symptomatique, c'est-à-dire la femme a des ménorrhagies, par exemple, des douleurs, etc., mais qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale, vous lui donnez un traitement médical.

Donc il y a quelques cas qui sont des indications au traitement chirurgical. Donc asymptomatique, traitement médical, entre les deux, le traitement chirurgical a des indications. Voici les indications.

Un fibrome de plus. Oui, oui, oui. Oui, oui.

Réversible, oui. Oui, c'est pour ça. Si vous donnez, après, en général, entre trois et six mois, vous arrêtez, parce que sinon vous allez tomber dans les effets secondaires de la ménopause.

Le problème cardiovasculaire, l'ostéoporose, etc. Oui, c'est six mois de traitement, pas plus. Donc, les indications du traitement chirurgical, soit un volume de fibromes supérieures, un volume de fibromes, pas de l'utérus, de fibromes supérieures ou égales à 10 centimètres, soit une femme chez qui vous avez donné un traitement médical, vous lui avez donné des projets statiques de synthèse pendant six mois, mais les hémorragies sont révélées au traitement médical, donc il faut l'opérer, soit c'est un fibrome qui est sous muqueux, je vous ai dit dès le début que le fibrome sous muqueux saigne énormément, il entraîne des métrorragies, il entraîne des anémies, parfois la femme vient en état de choc, ça, c'est une indication chirurgicale d'emblée, même s'il a un centimètre, parce qu'il va être rebelle au traitement d'emblée, donc ce n'est pas la peine de perdre le temps, il faut l'opérer.

En général, c'est des fibromes qu'on opère par hystéroscopie, il est au niveau de la cavité, donc on fait un hystéroscope avec une once et on résèque, donc c'est là où l'hystéroscopie est indiquée. Soit, bien sûr, il y a des complications compressives, l'urterre, la vessie, le rectum, s'il y a une compression, il faut traiter chirurgicalement pour enlever le fibrome, soit, bien sûr, c'est un fibrome sous séropéculé en torsion, parce que lorsqu'il est en torsion, il est ischémique, il est nécrotique, il y a des douleurs, etc., donc il faut l'enlever. Donc voilà, maintenant vous avez décidé le traitement chirurgical, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que c'est une myomectomie, enlever le fibrome, ou bien une hystérectomie, c'est-à-dire enlever tout l'utérus ? En général, ça c'est entre vous et votre patient.

Si la femme, en général, si la femme désire toujours avoir des grossesses, il faut faire une myomectomie. Si la femme ne désire plus, il a 4-5 enfants, il n'a pas besoin d'enfants, vous pouvez lui faire une hystérectomie. Bien sûr, vous allez expliquer à la femme que l'hystérectomie ne veut pas dire enlever le vagin, parce qu'elle n'a pas cette idée, elles vont être vides.

Oui, mais je parle en connaissance, depuis 1989 que je fais la gynécologie, donc vous voyez que je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup qui ont cette idée, donc il faut expliquer. J'explique avec le stylo, le côté où il y a les rapports, le côté que je vais enlever.

Il faut laisser les ovaires, parce que les femmes sont jeunes, il ne faut pas enlever les ovaires. Et il ne faut pas enlever le col de l'utérus, ça ne sert à rien, vous enlevez que le corps de l'utérus. Il y a des femmes qui ont des chutes de cheveux, qui ont des ongles qui sont craquelés, à l'anémie, etc.

Des femmes qui saignent tout le temps, même avec les problèmes conjugaux, etc. Ce n'est pas parce que c'est des ménorrhagie que c'est simple. Oui, ça ne va pas tuer, mais il y a un retentissement très important.

Devinez une femme qui, pendant tout le mois pratiquement, elle met des couches. C'est ça le problème de fibromes. Donc ça, c'est une discussion entre vous et votre malade, et puis c'est à lui de voir ce qu'il faut faire.

Vous voyez que je n'ai pas parlé du nombre ou de la taille de fibromes. Ça ne fait pas partie d'une indication d'hystérectomie. Ce n'est pas parce que c'est une femme qui a beaucoup de fibromes, ou bien une femme qui a un gros fibrome, qu'il faut lui faire une hystérectomie.

Non, on peut faire même 30 myomectomies chez une patiente en même temps, au même moment. Ça, je dis bien, il faut uniquement qu'il y ait du sang à côté parce que ça saigne. Voilà pour ce chapitre.

C'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Il est très fréquent, mais heureusement qu'il est rarement symptomatique. Le plus souvent, il est asymptomatique.

Et le traitement, je le répète encore, n'est pas systématique. Vous ne traitez pas systématiquement tout le temps qu'il y a un fibrome utère. Merci.